Robotic Process Automation を用いた術前 MRSA スクリーニングの自動報告体制の構築

◎杉山 裕衣[1)]、杉山 宗平[1)]、杉山 梨乃[1)]、藤上 卓馬[1)]、加藤 雄大[1)]、松久保 修[1)]、永田 悠起[1)]、田中 浩一[1)]
JA 愛知厚生連 豊田厚生病院[1)]

【はじめに】
『MRSA 感染症の診療ガイドライン 2024』では、心臓手術、整形外科手術等の清潔手術の MRSA 除菌が推奨されているが、当院では、外来で実施した MRSA スクリーニング結果の把握は主治医に依存しており、情報が見落とされる可能性が懸念されていた。そこで今回、RPA（Robotic Process Automation）を活用した自動報告システムを構築し、医療安全の向上を図ったので報告する。

【方法】
当院で使用している電子カルテ（HOPE/EGMAIN-GX）と感染管理システム（BactWeb）を介し、業務効率支援 RPA ソフト（WinActor）により自動報告システムを作成した。運用の流れは以下のとおりである。検査技師が同定・感受性検査を実施し、結果を電子カルテへ送信する。システムで毎日 18 時に新規発生情報の MRSA のうち、材料部位から『鼻腔粘液』を抽出し、「MRSA を検出した」と定型文を用いて、依頼医へメール送信と電子カルテ TOP 画面への記載を行う。2026 年 2 月より本運用を開始した。

【現状調査・結果】
システム導入前の事前調査として、2025 年 2 月 1 日～2026 年 1 月 31 日に実施した MRSA スクリーニング 524 件を対象とした。陽性は 14 件（2.6%）であり、陽性例はすべて心臓血管外科または整形外科の術前患者であった。そのうち除菌施行は 9 件、未施行は 5 件（内訳：緊急手術、手術中止、期間不足、除菌後再陽性、不明）であった。なお、本運用開始後は陽性例の発生を認めていない。

【考察】
外来での MRSA 陽性例は、入院患者に比べ ICT の監視から外れやすく、さらに低頻度ゆえに、検査室や臨床現場で見落とされるリスクが高い。今回構築したシステムにより、365 日自動での情報伝達経路が確立されたことは、医療安全を担保する上で極めて有意義である。実際の陽性例での稼働実績はまだ得られていないものの、システム自体は安定して動作しており、今後陽性例が発生した際の確実な情報共有と除菌施行率の向上に寄与することが期待される。

連絡先：0565-43-5000（内線 2979）